

1. Mr D. - Dépression liée au travail

C. Dejours, I. Gernet, *Psychopathologie du travail*, Issy, Elsevier-Masson, 2012, p. 70-71.

Monsieur D. est un ingénieur âgé de cinquante ans travaillant dans une grande entreprise spécialisée dans la technologie aéronautique. Il se décrit comme extrêmement engagé dans son travail et exigeant vis-à-vis de lui-même comme de ses collaborateurs. Il reconnaît que son activité professionnelle remplit un rôle important dans son équilibre personnel, mais qu'il vit avec le risque toujours présent d'être « débordé ». Il situe cet investissement du travail comme un héritage de son histoire familiale, où les hommes de la famille ont tous été amenés à occuper des postes à responsabilités importantes au service de la défense et de la sécurité du territoire, ou de l'expertise portant sur les nouvelles technologies. Il a été mis en arrêt de travail pour dépression quelques mois auparavant à la suite de l'interruption d'un projet sur lequel une partie des salariés de l'entreprise s'était mobilisée pendant plusieurs années. Il évoque la manière dont ce projet, visant à la conception d'un outil technique innovant, a suscité l'engouement au sein de l'entreprise : des moyens financiers importants ont été alloués, une grande partie des salariés a été sollicitée. Monsieur D. travaille pour ce projet sans relâche, renonce à ses congés, travaille le dimanche tout comme ses collègues, ce qui génère progressivement des tensions avec sa femme et le reste de sa famille. Le projet est finalement arrêté avant d'avoir abouti, pour des raisons budgétaires et une réorganisation des priorités dans un contexte de maîtrise des coûts qui suscitent l'incompréhension de la part des salariés. Monsieur D. expose alors le scénario conduisant au « deuil » qui va précipiter l'entrée dans la dépression : le projet étant « planté », des corbeilles géantes, faisant office de poubelles, sont déposées devant les bureaux et tous les documents relatifs au projet doivent y être « jetés ». Rien de ce qui a été étudié et réalisé ne fera l'objet d'une reprise ou d'une capitalisation pour des projets futurs. Tous les efforts auxquels il a consenti, les renoncements qu'il a réalisés lui semblent désormais inutiles au regard du résultat du travail et s'abîment dans les mouvements dépressifs de désinvestissement : les remords, la tristesse, l'inquiétude pour l'avenir et le sentiment de dévalorisation imprègnent désormais le vécu de Monsieur D.

2. Mr S. - Psychoses liées au travail

C. Dejours, I. Gernet, *Psychopathologie du travail*, Issy, Elsevier-Masson, 2012, p. 73-74.

Monsieur S. est un ouvrier du bâtiment âgé de quarante ans, reçu par le service des urgences d'un hôpital général, pour une symptomatologie délirante de type persécutif, évoluant depuis trois mois. Il présente des idées de référence - sentiment d'être suivi et observé, conviction qu'on le surveille et parle de lui à son insu. Sont également présentes des hallucinations acoustico-verbales, où des voix masculines l'injurient, le traitent de lâche, insultent sa femme et l'enjoignent de divorcer. Les troubles se sont déclenchés trois mois auparavant à la suite d'un accident du travail. Monsieur S. a chuté d'un échafaudage, mais est parvenu à se rattraper à un balcon, ce qui ne lui a laissé aucun dommage corporel. Une semaine plus tard, alors que Monsieur S. n'a pas souhaité prendre d'arrêt de travail, vont apparaître des troubles du sommeil, avec des cauchemars répétant la scène de la chute, une montée progressive de l'angoisse, de l'irritabilité et des idées de référence. L'investigation clinique va permettre de resituer la décompensation de Monsieur S. dans un contexte professionnel et familial particulier. Depuis son départ du Maroc et son arrivée en France à l'âge de vingt-deux ans, il a toujours travaillé dans la même entreprise et appris son métier sur le tas auprès de peintres en bâtiment professionnels. Il loge dans le même temps dans un foyer de travailleurs qu'il va quitter pour s'installer dans un appartement avec sa femme et ses trois enfants au moment de leur venue en France un an auparavant. Au cours de cette période, des changements vont également se produire dans l'organisation du travail installant progressivement une transformation des contraintes du travail pour Monsieur S. et ses collègues. C'est le fils du patron, qui reprend l'entreprise et instaure une augmentation des cadences associée à une affectation sur les chantiers (intérieur, extérieur) ne tenant pas compte de la qualification des ouvriers.

La convivialité qui existait précédemment entre les ouvriers s'efface pour laisser la place à la méfiance et la suspicion entre collègues pour savoir qui dénonce les pots et les pratiques de consommation d'alcool entre collègues, au cours desquels on se retrouve pour « se raconter le boulot ». L'investissement de sa vie de famille maintenant présente physiquement auprès de lui est important à ses yeux et le conduit à manquer les temps de retrouvailles entre collègues. Il se retrouve confronté à un isolement progressif du collectif de travail, collectif déjà déstabilisé par les changements d'organisation du travail. La crise psychique consécutive à l'accident révèle la faillite des processus défensifs face au risque mortel : Monsieur S. ne peut plus avoir recours à l'idéologie défensive virile qui structurait le collectif de travail (blagues, conduites de défi et de bravade face au risque, consommation d'alcool entre « copains »), le protégeait contre la peur et lui permettait de se défendre contre la souffrance engendrée par l'activité de travail dangereuse. Les hallucinations (voix d'hommes) le somment de

divorcer, comme une tentative de solder les difficultés psychologiques issues du conflit entre les exigences défensives structurées par les conduites viriles qui dénie la peur et la vulnérabilité du corps d'une part et l'engagement affectif auprès de sa femme et de ses enfants qui l'amène à devoir prendre soin d'eux d'autre part. L'épisode psychotique apparaît comme la résultante de la sollicitation simultanée de registres affectifs habituellement séparés par les opérations défensives : Monsieur S. ne parvient pas à simultanément se montrer tendre et attentionné et opposer un déni à la souffrance.

L'élaboration psychique de la contradiction existant entre les contraintes de travail et les investissements affectifs de sa vie privée au cours d'un travail psychothérapique sera rendue possible par un travail d'interprétation portant sur sa situation actuelle et par un changement de poste de travail, décidé par Monsieur S. lui-même, conduisant à la disparition complète de la symptomatologie psychotique sans traitement neuroleptique.

2. Mr S. - Psychoses liées au travail

C. Dejours, I. Gernet, *Psychopathologie du travail*, Issy, Elsevier-Masson, 2012, p. 77-78.

Dans les ONG, les responsables sont préoccupés de la gestion du « stress et du trauma » par les volontaires intervenant en situation d'urgence sur le terrain (catastrophes naturelles, guerres civiles et conflits armés...), mais également lors des retours de mission. La participation à des programmes de reconstruction, ou à des aides au développement qui se révèlent parfois préjudiciables pour certaines catégories de population et instaurent des discriminations concernant les « bénéficiaires », s'avère contradictoire avec les valeurs qui ont présidé à l'engagement humanitaire (altruisme, compassion...) et génère de la souffrance. La poursuite du travail en situation d'injustice nécessite le déploiement de stratégies collectives de défense qui « gauchissent » la pensée et s'appuient sur des constructions symboliques qui stigmatisent ou disqualifient les populations locales (des « pays sous-développés », ou « moins avancés »), en vue d'entretenir le déni sur la réalité qui fait souffrir.

Le retour de mission se révèle être une période particulièrement « sensible » et propice au déclenchement de troubles post-traumatiques dans la mesure où il coïncide avec l'arrêt du recours à l'idéologie collective. Apparaissent en effet des troubles de type dépressif, des troubles du sommeil avec des reviviscences nocturnes des épisodes critiques des missions, des manifestations anxieuses, des difficultés de concentration, une irritabilité, mais aussi de la déception, de la culpabilité... Ces manifestations cliniques seraient les témoins de l'émergence d'un travail de conflictualisation des motions pulsionnelles qui se voyaient jusque-là endiguées ou contenues par les constructions symboliques et idéologiques véhiculées par les stratégies collectives de défense.

4. Jeannine - Troubles du jugement et de la pensée

C. Dejourn, I. Gernet, *Psychopathologie du travail*, Issy, Elsevier-Masson, 2012, p. 102-103.

Jeannine est une femme de quarante ans, reçue en consultation dans un service psychiatrique pour des troubles cognitifs et psychomoteurs. Elle apparaît épuisée, irritable, présentant des insomnies et ralentie sur le plan psychomoteur. Elle présente également des troubles de la mémoire : perd ses affaires, interrompt en cours de route ses activités sans se souvenir du motif d'interruption ; ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration. Mais elle semble particulièrement inquiète concernant l'aggravation des troubles psychomoteurs qui se traduisent par la perte de ses capacités manuelles et créatrices dont elle était fière : elle casse les objets, elle rate ses recettes de cuisine, elle se trouve démunie pour la réalisation des activités les plus simples. Elle choisit de s'isoler pour éviter d'alerter ses relations sociales et familiales, mais se montre soucieuse à propos de son travail, dans lequel ses troubles commencent à lui poser problèmes. Elle occupe, depuis un an, un poste d'employée de commerce dans un grand magasin spécialisé dans l'habillement et le tissu d'ameublement. Elle a trouvé ce poste à la suite de la construction d'un projet professionnel de reprise d'emploi élaboré parallèlement à un travail psychothérapique initié après une tentative de suicide trois ans auparavant. Le travail clinique réalisé à la suite du passage à l'acte avait conduit à resituer le geste suicidaire (absorption de médicaments) dans le contexte de transformations de la vie familiale (départ des enfants du domicile, retour à une vie de couple, absence de projet « utile » à réaliser, attente anxieuse du vieillissement, de la maladie et de la mort). L'insertion professionnelle qui a suivi a contribué à activer de travail ses compétences et « qualités féminines » qui avaient étayé son identité dans les tâches domestiques et familiales.

La crise psychique actuelle s'inscrit dans une évolution de sa situation de travail suite à la mise en place par la direction de restructurations basées sur la polyvalence des effectifs et sur la flexibilité des horaires. Les activités des vendeuses et vendeurs se voient progressivement transformées : il est attendu de pouvoir assurer de manière interchangeable les services à la clientèle, la gestion des stocks, de passer des commandes, de faire la manutention des vêtements et tissus, de remplacer les collègues absents, de former les nouvelles recrues... L'imprévisibilité des tâches, associée au manque de reconnaissance et à la perte d'autonomie dans le travail, pèse de manière pénible sur les salariés et contribue à dégrader l'ambiance et la solidarité entre collègues. Les troubles cognitifs qui se déclenchent résultent de la parcellisation des tâches qui induit un mode d'investissement psychique fragmenté : le travail à accomplir est devenu « irréprésentable ». Le travail d'élaboration du mouvement de déstructuration cognitive à partir d'une prise en charge spécifique (consultations avec la psychiatre centrées sur la situation actuelle de Jeannine et séances de relaxation) va aboutir à la sédation de la symptomatologie. Une reprise du

travail après un arrêt maladie de trois mois se fera progressivement (mi-temps thérapeutique) dans le contexte d'un changement dans l'organisation du travail déclenché à l'issue d'un signalement sur les problèmes de santé mentale effectué par le médecin du travail et de la mobilisation conjointe de Jeannine et de ses collègues auprès de l'inspection du travail.

5. Mme V. - Tentative de suicide

C. Dejours, I. Gernet, *Psychopathologie du travail*, Issy, Elsevier-Masson, 2012, p. 106-107.

Madame V. B. est une femme de quarante-trois ans qui travaille comme cadre dans une entreprise high-tech multinationale. Suite à ses études scientifiques, elle fait une brillante carrière qui la conduit à prendre en charge la responsabilité du service de formation de son entreprise. À la suite de l'adoption d'un enfant avec son mari avec lequel elle a déjà trois filles, elle demande à travailler à temps partiel, demande qui lui sera accordée mais mal vue par sa hiérarchie. Commencent alors la déstabilisation et le désaveu de son engagement dans son travail : les responsabilités vont lui être retirées et des missions peu qualifiées vont lui être confiées. Des brimades et des manœuvres humiliantes pour la disqualifier la conduisent à prendre un congé maladie et suivre un traitement psychiatrique en ambulatoire pour dépression. À la reprise du travail, des tâches déqualifiées et subalternes lui sont à nouveau confiées. Elle se suicide peu de temps après en se jetant du haut d'un pont à proximité de son entreprise. Elle laisse une lettre à la déléguée du comité d'entreprise, lui demandant de la rendre publique après sa mort. L'histoire du suicide de Madame V.B. met en évidence les rapports de domination qui alimentent la culture de performance de l'entreprise, et permet de discuter l'hypothèse de nouvelles formes de servitude dans le travail. Les éléments recueillis auprès de l'entourage témoignent de son investissement passionné dans son travail et de sa réussite dans les missions qu'elle entreprend. La vie familiale représente également un pôle d'attachement particulièrement important. Une des caractéristiques de Madame V.B. avant son suicide était d'être d'une grande exigence et de présenter une forme de rigidité morale et psychologique qui lui permettait d'effectuer un travail de grande qualité, reconnu comme tel par son employeur et ses collègues. C'est aussi ce qui la conduit à ne pas céder aux brimades et à l'humiliation une fois le mouvement de disgrâce amorcé. Le point central de l'analyse étiologique du suicide porte donc sur l'ambiguïté de la vulnérabilité psychologique de Madame V.B. - ses caractéristiques psychologiques lui ont permis de répondre aux exigences de qualité et de maintenir une performance de haut niveau, mais précipitent en même temps le mouvement de déstabilisation psychologique qui conduit à la décompensation. La « solution » de pouvoir opposer à la situation critique un désinvestissement du travail s'est avérée impossible, au regard de l'implication subjective nécessaire pour réussir à dépasser les obstacles, endurer les difficultés et trouver une forme d'accomplissement dans le travail. Un facteur supplémentaire revient à l'analyse de la défection des collègues devant la situation d'injustice vécue par Madame V.B. - au management exigeant la soumission et l'adhésion aux valeurs de la performance et de l'autonomie répond une forme spécifique de communauté professionnelle organisée par une « convivialité stratégique »

6. Mr L. - Burn-out avec troubles anxio-dépressifs et atteinte du sentiment d'efficacité professionnelle

Monsieur L. est un homme de trente-huit ans, reçu en consultation à la demande de son médecin traitant pour un épuisement intense associé à des troubles anxio-dépressifs évoluant depuis environ six mois. Il décrit une fatigue persistante, des troubles du sommeil avec réveils nocturnes anxieux, une irritabilité croissante ainsi qu'un sentiment d'échec professionnel et de perte de sens de son activité.

Monsieur L. travaille depuis douze ans comme chef de projet dans une entreprise de services numériques. Jusqu'à récemment, il décrivait son travail comme stimulant, valorisant et porteur de reconnaissance. Il s'était progressivement vu confier des responsabilités croissantes et s'était fortement investi dans la réussite des projets qui lui étaient confiés, au prix d'une grande disponibilité (heures supplémentaires fréquentes, déplacements réguliers, travail le soir à domicile).

Un changement de direction, intervenu un an auparavant, a profondément modifié l'organisation du travail. Une nouvelle politique de rentabilité a été instaurée, s'accompagnant d'une intensification des cadences, d'une réduction des délais de livraison et d'une mise en concurrence des équipes. Les marges de manœuvre dans la conduite des projets ont été fortement réduites, avec l'imposition de procédures standardisées et d'indicateurs de performance chiffrés. Monsieur L. décrit une perte d'autonomie décisionnelle et une difficulté croissante à garantir la qualité du travail fourni.

Parallèlement, plusieurs membres expérimentés de son équipe ont quitté l'entreprise et n'ont pas été remplacés. Monsieur L. s'est alors retrouvé à assumer une charge de travail accrue tout en devant encadrer de nouveaux collaborateurs peu formés. Il évoque un sentiment d'isolement progressif, les temps d'échange informels entre collègues ayant été remplacés par des réunions de suivi centrées sur les objectifs de performance.

Les premiers signes de décompensation apparaissent lorsqu'un projet important, dont il avait la responsabilité, est livré avec des défauts techniques majeurs. Il reçoit alors des critiques sévères de sa hiérarchie, sans reconnaissance des contraintes organisationnelles rencontrées. Cet épisode marque pour lui une rupture : il décrit la perte de confiance en ses compétences, la peur constante de commettre des erreurs et l'impression de ne plus être à la hauteur.

Peu à peu, il met en place des stratégies de surinvestissement pour tenter de compenser ses difficultés (augmentation du temps de travail, vérifications répétées, impossibilité de déléguer). Ces conduites aggravent son épuisement et contribuent à l'installation d'un cercle vicieux associant fatigue, baisse de l'efficacité et auto-dévalorisation. Sur le plan familial, sa compagne lui reproche son indisponibilité et son irritabilité, ce qui accentue son sentiment d'échec global.

Au moment de la consultation, Monsieur L. dit « ne plus ressentir aucun plaisir à travailler » et envisage de démissionner sans projet alternatif. Il exprime une grande anxiété anticipatoire à l'idée de retourner au travail et des idées de retrait social. L'analyse clinique met en évidence une atteinte du rapport subjectif au travail, liée à la contradiction entre les exigences de qualité auxquelles il reste attaché et l'organisation du travail qui l'empêche de les satisfaire.

La prise en charge s'oriente vers un arrêt de travail temporaire, un accompagnement psychothérapeutique centré sur l'élaboration de cette conflictualité et une réflexion sur les conditions de reprise, incluant un aménagement du poste ou une réorientation professionnelle.

7. Mme R. – Difficulté de l'engagement subjectif et fatigue morale

Madame R. est une femme de quarante-cinq ans, reçue en consultation à la demande du médecin du travail pour des plaintes de fatigue persistante et de difficultés de concentration au travail. Elle ne présente pas de symptomatologie psychiatrique constituée, mais évoque un sentiment de lassitude, une perte d'élan dans son activité et des tensions relationnelles inhabituelles avec ses collègues.

Elle occupe depuis près de quinze ans un poste de responsable d'accueil dans une structure culturelle municipale. Elle décrit son travail comme ayant longtemps été une source de satisfaction, reposant sur le contact avec le public, la médiation culturelle et l'animation d'une petite équipe stable et soudée. Elle souligne l'importance qu'elle accordait à la qualité de l'accueil et à la transmission des valeurs culturelles de l'institution.

Depuis deux ans, la municipalité a engagé une réorganisation visant à rationaliser le fonctionnement des services. Les effectifs ont été réduits, les missions redéfinies et de nouveaux outils de gestion informatisés ont été introduits. Madame R. doit désormais assurer simultanément l'accueil, la gestion administrative, la promotion des événements sur les réseaux sociaux et la production de tableaux de suivi d'activité.

Elle décrit une difficulté à « se représenter » son travail dans cette nouvelle configuration, les tâches se succédant rapidement sans continuité apparente. Elle exprime un sentiment diffus de faire « du remplissage » et de ne plus pouvoir s'appuyer sur des critères qualitatifs pour juger de son travail. Les échanges avec sa hiérarchie se centrent désormais sur des indicateurs chiffrés de fréquentation et de rentabilité.

Dans ce contexte, Madame R. note une modification de son rapport aux usagers : elle dit se surprendre à écourter les échanges, à se montrer moins disponible, ce qui la met en difficulté au regard de ses valeurs professionnelles. Elle évoque également une certaine irritabilité en fin de journée et des difficultés à « décrocher » mentalement du travail le soir, sans toutefois présenter d'insomnie majeure.

Sur le plan collectif, elle décrit une dégradation de l'ambiance au sein de l'équipe : les temps de coordination ont été réduits, chacun étant davantage centré sur ses propres tâches. Elle se sent moins soutenue et hésite à partager ses difficultés, de peur d'apparaître comme « résistante au changement ».

L'entretien clinique met en évidence une tension entre l'idéal professionnel construit au cours de sa carrière et les exigences actuelles de l'organisation du travail, tension qui reste peu élaborée par Madame R. et s'exprime principalement sous forme de fatigue morale et de désengagement progressif.

Une intervention du médecin du travail et un espace de parole collectif sont envisagés afin de permettre une mise en discussion des transformations en cours

et de soutenir les possibilités de réinvestissement du travail par Madame R. et ses collègues.

8. Mr B. - Manifestations somatiques fonctionnelles

Monsieur B. est un homme de cinquante ans, adressé par son médecin généraliste en consultation spécialisée pour des douleurs lombaires persistantes, associées à des céphalées de tension et des troubles digestifs intermittents (ballonnements, douleurs abdominales diffuses), évoluant depuis environ huit mois. Les explorations médicales réalisées (imagerie lombaire, bilan biologique) n'ont pas mis en évidence de pathologie organique expliquant l'intensité des plaintes.

Monsieur B. travaille depuis plus de vingt-cinq ans comme agent logistique dans un entrepôt de distribution alimentaire. Il décrit une bonne santé générale jusque-là et une grande fierté à tenir un poste physiquement exigeant. Il insiste sur son assiduité et le fait de n'avoir « jamais été arrêté » auparavant.

L'apparition des douleurs coïncide avec une réorganisation récente de l'entrepôt, marquée par l'introduction de nouveaux logiciels de gestion des stocks et par une modification des circuits de préparation des commandes. Les tournées ont été accélérées, les objectifs de productivité revus à la hausse et les temps de pause réduits. Les salariés sont désormais équipés de terminaux portables qui enregistrent en temps réel leurs performances.

Monsieur B. indique qu'il a d'abord ressenti des tensions musculaires en fin de journée, qu'il attribuait à la fatigue. Progressivement, les douleurs se sont installées de manière plus constante, s'accompagnant de céphalées en fin de semaine et de troubles digestifs qu'il relie à des repas pris rapidement sur le lieu de travail. Il évoque aussi une sensation de « boule au ventre » lorsqu'il se rend au travail le matin.

Il souligne qu'il n'ose pas ralentir son rythme, de peur de ne pas atteindre les objectifs et d'être mal perçu par sa hiérarchie. Il décrit un climat d'entrepôt plus tendu, où chacun

« regarde ses chiffres » et où les échanges entre collègues se font plus rares. Les moments de solidarité liés à l'entraide sur les charges lourdes ont diminué, chacun étant incité à suivre strictement son circuit.

À domicile, Monsieur B. dit continuer à « tenir le coup », mais sa conjointe remarque qu'il est plus irritable et qu'il se plaint davantage de douleurs le soir. Il a réduit certaines activités de loisir physique qu'il pratiquait auparavant, craignant d'aggraver ses lombalgies.

L'entretien clinique met en évidence une difficulté à mettre en mots le vécu de contrainte et de pression lié à l'évolution de l'organisation du travail, ces tensions s'exprimant préférentiellement sur le registre corporel. Les manifestations somatiques apparaissent comme des modes d'expression de la conflictualité entre les exigences de productivité et le souci de préserver son corps et son image de travailleur fiable.

Une prise en charge associant suivi médical, aménagement temporaire du poste et accompagnement visant à élaborer le lien entre les symptômes et la situation de travail est proposée, en lien avec le médecin du travail.

9. Mme C. - Harcèlement « horizontal »

Madame C., trente-deux ans, est adressée en consultation par le médecin du travail.

Depuis environ un an, elle décrit une fatigue qui s'installe progressivement, particulièrement marquée en fin de journée. Le soir, elle a du mal à « décrocher » du travail : certaines situations lui reviennent en tête de manière répétée et elle se surprend à repenser à ce qu'elle a fait ou aurait pu faire différemment. Elle dit aussi avoir plus de difficulté à rester concentrée au cours de ses journées. Depuis quelques mois, l'idée d'aller travailler le matin lui pèse davantage qu'auparavant.

Elle est infirmière dans un service de médecine polyvalente depuis cinq ans. Elle parle de son métier avec attachement, en insistant sur l'importance de la relation avec les patients et sur le fait de « bien faire son travail ». À ses débuts dans le service, elle garde le souvenir d'une équipe soudée, où les collègues s'entraidaient et où l'on pouvait échanger facilement, même si le rythme de travail était déjà soutenu.

Au fil du temps, l'équipe s'est modifiée, avec plusieurs départs et l'arrivée de nouveaux professionnels. Dans ce contexte, certaines habitudes de travail semblent s'être installées, notamment dans la manière de se répartir les tâches ou de gérer les priorités. Madame C. dit ne pas toujours s'y retrouver et avoir parfois exprimé son désaccord, notamment lorsqu'elle estime que certaines façons de faire peuvent nuire à la qualité des soins, par exemple dans les transmissions ou dans certaines délégations.

Elle a le sentiment qu'à partir de ces moments-là, quelque chose a changé dans ses relations avec ses collègues. Les échanges informels sont devenus plus rares. Il lui arrive de découvrir tardivement des informations concernant les patients dont elle s'occupe. Certaines remarques, formulées sur le ton de la plaisanterie, visent son « perfectionnisme ». Elle évoque aussi des situations où des erreurs lui ont été reprochées devant les autres, sans qu'elle puisse intervenir sur le moment.

Progressivement, elle dit ne plus se sentir « comme avant » dans l'équipe. Elle remarque qu'elle n'est plus systématiquement associée aux moments de pause et qu'elle a l'impression d'être davantage observée dans son travail. Cela la conduit à passer plus de temps sur certaines tâches, à vérifier plusieurs fois ce qu'elle fait, et parfois à rester plus tard pour terminer ce qu'elle a commencé. Elle se sent de plus en plus fatiguée, sans pour autant parvenir à réduire ce fonctionnement.

Quand elle tente de comprendre ce qui se passe, elle hésite entre se dire qu'elle a peut-être une part de responsabilité et le sentiment que la situation est injuste. Elle dit ne pas savoir à qui en parler dans le service. Elle craint que le fait d'évoquer ces difficultés soit mal perçu, dans un contexte où chacun semble déjà très sollicité.

10. Mme T. - Épuisement compassionnel et désinvestissement affectif

Madame T., trente-six ans, est éducatrice spécialisée dans un foyer accueillant des adolescents placés au titre de la protection de l'enfance. Elle est adressée en consultation par le médecin du travail dans un contexte de fatigue qui s'installe depuis plusieurs mois. Elle dit se sentir de plus en plus éprouvée, dort moins bien qu'auparavant et se décrit comme plus irritable. Elle a aussi le sentiment de ne plus réagir de la même manière aux situations rencontrées dans son travail.

Elle exerce dans cette structure depuis huit ans. Elle évoque un engagement initial fort, nourri par le désir d'accompagner des jeunes en difficulté et de participer à leur reconstruction. Elle parle d'une proximité importante avec les adolescents, fondée sur l'écoute, la disponibilité et la relation de confiance.

Depuis quelque temps, elle observe des changements dans le public accueilli. Les situations lui semblent plus complexes, marquées par des parcours de vie plus difficiles et des comportements parfois violents ou imprévisibles. En parallèle, l'équipe a été fragilisée par plusieurs départs, non remplacés, ce qui a modifié l'organisation du travail et augmenté les temps de présence.

Dans ce contexte, Madame T. se trouve confrontée de manière répétée à des récits de vie éprouvants. Elle remarque que certaines situations continuent de l'habiter après sa journée de travail. Le soir, au moment de se coucher, il lui arrive de repenser à ce qu'elle a entendu ou vécu, parfois sous forme d'images qui s'imposent à elle. Elle dit aussi se sentir démunie face à la répétition de certaines conduites chez les adolescents, malgré les efforts engagés.

Progressivement, elle décrit une modification de sa manière d'entrer en relation avec les jeunes. Elle se surprend à limiter certains échanges, à écourter des temps d'entretien ou à garder davantage de distance. Elle dit que cela lui permet de « tenir », au moins sur le moment. Mais elle éprouve en même temps un malaise face à cette évolution, en décalage avec la manière dont elle concevait son métier.

Elle mentionne également des tensions physiques, des maux de tête plus fréquents et une fatigue qui persiste même après les périodes de repos. En dehors du travail, elle se sent moins disponible, a réduit certaines activités et reste davantage chez elle. Son entourage lui fait remarquer qu'elle semble préoccupée, parfois absente.

Elle décrit aussi une évolution du fonctionnement de l'équipe. Les temps d'échange entre collègues lui paraissent plus rares, les réunions étant centrées sur l'organisation et les urgences à gérer. Elle dit ne pas vraiment trouver d'espace pour parler de ce qu'elle vit dans son travail. Elle hésite à aborder ces difficultés, craignant que cela soit mal perçu dans un contexte où chacun semble devoir « tenir ».

Quand elle évoque sa situation, elle insiste à la fois sur son attachement à son métier et sur la difficulté croissante à continuer à s'y engager comme auparavant. Elle dit

avoir le sentiment que quelque chose s'est modifié, sans parvenir à dire précisément quoi, sinon que « ça prend plus de place qu'avant ».

11. Mr H. - Surmenage chronique, désorganisation du rythme de vie et décès brutal au travail

Monsieur H. est un homme de quarante-neuf ans, cadre intermédiaire dans une entreprise de transport et de logistique. Il est retrouvé inanimé à son poste de travail un matin, victime d'un arrêt cardiaque massif. Les éléments médicaux recueillis secondairement ne mettent pas en évidence de pathologie cardiovasculaire antérieure connue. L'analyse de sa trajectoire professionnelle et des mois précédant le décès permet d'éclairer les conditions ayant conduit à cette issue.

Monsieur H. travaille dans l'entreprise depuis plus de vingt ans. Il a progressivement accédé à des fonctions de responsable d'exploitation, supervisant les tournées de livraison, la gestion des équipes de chauffeurs et le respect des délais contractuels avec les clients. Il est décrit par ses collègues et sa hiérarchie comme un salarié « très impliqué », fiable et disponible, acceptant volontiers des charges de travail supplémentaires.

Dans les dix-huit mois précédant son décès, l'entreprise connaît une croissance rapide liée à l'obtention de nouveaux contrats. Cette expansion s'accompagne d'une réorganisation interne et d'une réduction des effectifs administratifs, les responsabilités étant redistribuées sur un nombre plus restreint de cadres. Monsieur

H. se voit confier la coordination de plusieurs secteurs auparavant distincts.

Les horaires de travail s'allongent progressivement : il commence plus tôt le matin pour gérer les départs des chauffeurs et reste tard le soir pour traiter les incidents de livraison et les réclamations clients. Il emporte régulièrement du travail à domicile le week-end. Ses collègues rapportent qu'il prenait rarement ses pauses et qu'il déjeunait souvent devant son écran.

Sur le plan subjectif, les témoignages de son entourage décrivent une fatigue croissante, des troubles du sommeil et une irritabilité inhabituelle. Monsieur H. évoquait peu ses difficultés, se contentant de dire qu'« il fallait tenir » le temps que la nouvelle organisation se stabilise. Il exprimait également une forte préoccupation pour la satisfaction des clients et la crainte de pénalités financières en cas de retard.

La sphère familiale apparaît également affectée : son épouse signale une diminution des temps partagés, un repli sur les préoccupations professionnelles et une difficulté à « décrocher » du travail même lors des moments de repos. Elle rapporte qu'il consultait fréquemment ses messages professionnels le soir et la nuit.

Dans les semaines précédant le décès, plusieurs incidents logistiques majeurs surviennent (retards de livraison, pannes de véhicules), augmentant encore la pression sur les équipes. Monsieur H. assume personnellement la gestion de ces situations, multipliant les journées de travail prolongées sans récupération effective.

L'analyse clinique met en évidence une accumulation de facteurs de surmenage : intensification et allongement du temps de travail, responsabilité élevée sans moyens supplémentaires, forte implication subjective et difficulté à poser des limites. L'absence de reconnaissance explicite et de régulation collective du travail a contribué à maintenir cette dynamique de surinvestissement.

Le décès de Monsieur H. peut être compris, dans ce contexte, comme l'issue extrême d'un processus d'épuisement physiologique et psychique lié au travail, caractéristique des situations de karoshi, où la défaillance somatique survient sur un terrain de surcharge chronique et de désorganisation des rythmes de vie.

12. Mme E. - Conflit éthique et atteinte du rapport au travail

Madame E., quarante et un ans, travaille comme conseillère dans une agence locale d'un organisme public d'accompagnement à l'emploi. Elle est adressée en consultation par son médecin traitant. Depuis plusieurs mois, elle décrit une fatigue qui persiste malgré le repos, des tensions dans le corps et un malaise diffus qu'elle relie à son travail. Elle évoque également des pensées qui reviennent fréquemment sur certaines situations professionnelles, notamment des décisions qu'elle a prises ou dû appliquer.

Elle exerce dans cette structure depuis plus de dix ans. Elle parle de son parcours avec attachement, en soulignant l'importance qu'elle accordait à l'accompagnement individualisé des personnes et à la relation construite avec elles dans la durée. Elle décrit son travail comme ayant longtemps reposé sur la recherche de solutions adaptées à chaque situation.

Depuis quelque temps, les modalités de travail ont évolué. Elle explique que de nouveaux objectifs ont été introduits, avec des attentes chiffrées concernant les retours à l'emploi. Le suivi des usagers s'est standardisé, les procédures se sont renforcées et le temps consacré à chaque personne a diminué. Certaines aides sont désormais soumises à des critères plus stricts.

Dans ce contexte, Madame E. se trouve confrontée à des situations où elle doit proposer des orientations ou appliquer des décisions qui ne lui paraissent pas toujours adaptées. Elle évoque des moments où elle a dû notifier des mesures à des personnes en difficulté, tout en ayant le sentiment que ces décisions pouvaient aggraver leur situation. Elle dit avoir été marquée par certains de ces échanges, qui lui reviennent ensuite en tête.

Elle décrit une tension entre ce qui est attendu d'elle dans son travail et la manière dont elle conçoit son rôle. Elle dit parfois avoir le sentiment de ne plus agir comme elle le faisait auparavant, et s'interroge sur ce que cela change dans sa manière de se percevoir comme professionnelle.

Pour continuer à travailler, elle explique avoir modifié sa façon de faire. Elle applique davantage les procédures telles qu'elles sont prescrites, en limitant certains échanges avec les usagers les plus en difficulté. Elle dit que cela lui permet, sur le moment, de se sentir moins affectée, mais elle a aussi le sentiment que son travail a perdu une partie de ce qui faisait son intérêt.

Elle remarque que ses collègues rencontrent des difficultés proches des siennes, mais que ces questions sont peu abordées collectivement. Les réunions d'équipe portent surtout sur les résultats à atteindre et le respect des procédures. Elle hésite à exprimer ses réserves, craignant que cela soit interprété comme un manque d'adaptation ou de professionnalisme.

En dehors du travail, elle se surprend à repenser à certaines situations, sans toujours parvenir à s'en détacher. Elle dit se sentir plus fatiguée qu'avant, sans identifier

clairement ce qui pourrait lui permettre d'aller mieux. Elle insiste à la fois sur son attachement à son métier et sur le fait que « quelque chose ne va plus comme avant », sans réussir à le formuler complètement.

13. Mr P. - Désengagement professionnel et altération de l'estime de soi

Monsieur P., trente-quatre ans, travaille comme employé administratif dans une grande entreprise d'assurance. Il est adressé en consultation par son médecin traitant. Depuis environ un an, il décrit une fatigue persistante, des difficultés à se concentrer et un sentiment diffus de perte de confiance en lui dans le cadre de son travail. Il évoque également un ennui de plus en plus présent au cours de ses journées professionnelles.

Il a été recruté trois ans auparavant à un poste de gestionnaire de dossiers, correspondant à sa formation. Il garde le souvenir d'un début de parcours satisfaisant, marqué par un apprentissage progressif et une implication dans ses missions. Il dit avoir trouvé sa place dans le service et avoir développé des compétences qu'il pensait pouvoir continuer à mobiliser.

Un changement d'organisation est intervenu environ un an et demi plus tôt. Une partie des activités a été automatisée et la répartition du travail a été modifiée. Certaines tâches qu'il réalisait auparavant ont disparu, et il s'est vu confier des activités plus ponctuelles, souvent simples, qui occupent seulement une partie de son temps.

Il décrit désormais des journées au cours desquelles les périodes d'activité alternent avec de longs moments où il ne sait pas quoi faire, tout en restant à son poste. Dans un premier temps, il a cherché à obtenir davantage de travail auprès de sa hiérarchie, mais les réponses sont restées vagues, évoquant une situation temporaire.

Progressivement, il explique avoir modifié son comportement pour éviter que cette situation ne soit trop visible. Il consulte des documents, réorganise ses dossiers, ou s'occupe à des tâches qu'il sait peu utiles, afin de donner l'impression d'être occupé. Il dit éprouver un certain malaise à l'idée que ses collègues puissent remarquer qu'il n'a pas réellement de travail à faire.

Au fil du temps, il a le sentiment que quelque chose s'est modifié dans la manière dont il se perçoit. Il dit douter davantage de ses capacités, se sentir moins sûr de lui et craindre de ne plus être capable d'occuper un poste plus exigeant. Il utilise parfois l'expression de se sentir « rouillé ».

Il décrit également une fatigue particulière : malgré une activité réduite, il se sent vidé en fin de journée, avec peu d'énergie pour ses activités personnelles. Il associe cela à l'ennui et au manque de stimulation dans son travail.

Les relations avec ses collègues restent correctes, mais il a le sentiment de ne pas être pleinement impliqué dans la vie du service. Les réunions portent sur des dossiers auxquels il ne participe pas, ce qui renforce son impression d'être en marge.

En évoquant sa situation, il oscille entre l'idée qu'il devrait peut-être « faire avec » et une inquiétude quant à l'évolution de sa trajectoire professionnelle. Il dit avoir du mal à se projeter et à comprendre comment la situation pourrait évoluer, tout en

restant attaché à l'idée de retrouver un travail qui mobilise davantage ses compétences.

14. Mr G. - Perte de sens du travail et désengagement subjectif

Monsieur G., trente-neuf ans, travaille comme chargé de communication dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. Il est adressé en consultation par le médecin du travail. Depuis plusieurs mois, il décrit une fatigue qui s'installe, une difficulté à s'engager dans ses missions et un intérêt qui s'est progressivement émoussé pour son travail. Il évoque aussi une impression diffuse que ce qu'il fait a moins de valeur qu'auparavant.

Il occupe ce poste depuis sept ans. Il parle de ses débuts avec enthousiasme, en insistant sur l'intérêt qu'il portait aux produits de l'entreprise et sur le sentiment de contribuer à la mise en valeur d'innovations qu'il jugeait utiles. Il évoque le plaisir qu'il trouvait à travailler avec les équipes techniques et à rendre accessibles des contenus complexes.

Depuis quelque temps, les orientations de l'entreprise ont évolué. Les actions de communication se centrent davantage sur des objectifs commerciaux, avec une mise en avant des performances et de la rentabilité. Monsieur G. explique que certains messages lui paraissent moins en lien avec les caractéristiques réelles des produits ou avec les besoins des utilisateurs.

Dans ce contexte, il se retrouve à produire des supports qu'il a du mal à s'approprier. Il décrit un certain malaise lorsqu'il doit mettre en avant des éléments qu'il juge secondaires, ou lorsqu'il a le sentiment de simplifier à l'excès certaines informations. Il parle d'un décalage entre ce qu'il pensait faire en exerçant ce métier et ce qu'il lui est demandé aujourd'hui.

Pour continuer à travailler, il explique avoir adopté une attitude plus conforme aux attentes de sa hiérarchie. Il réalise les tâches demandées, mais dit les accomplir de manière plus distante. Il lui arrive de repousser certaines missions, de se sentir moins concentré et de rencontrer des difficultés à mobiliser sa créativité, alors que cela constituait auparavant une part importante de son activité.

Il décrit une forme de lassitude qui s'installe, ainsi qu'un questionnement plus large sur son parcours professionnel. Il a parfois l'impression de « perdre son temps » et dit ne plus très bien comprendre ce qu'il apporte dans son travail. En dehors du cadre professionnel, il évite d'en parler, expliquant qu'il ne sait plus vraiment comment décrire ce qu'il fait.

Il évoque également le fonctionnement de son équipe. Il a le sentiment que les orientations actuelles sont globalement acceptées, ou du moins peu discutées. Les réunions portent essentiellement sur les résultats attendus et les objectifs à atteindre. Il dit ne pas trouver d'espace pour échanger sur le sens du travail ou sur les questions qu'il se pose.

En parlant de sa situation, il insiste à la fois sur son attachement à son métier et sur le fait qu'il ne parvient plus à s'y engager comme auparavant. Il évoque l'idée qu'il

pourrait continuer ainsi, mais aussi celle qu'il lui faudrait peut-être envisager autre chose, sans savoir précisément quoi ni comment.

15. Mme C. – Harcèlement moral (mobbing) et décompensation anxio-dépressive

Madame C., trente-six ans, travaille comme chargée de clientèle dans une agence bancaire régionale. Elle est reçue en consultation à la demande de son médecin traitant. Depuis plusieurs mois, elle décrit un état de tension quasi permanent, avec des moments où l'angoisse devient très intense au cours de la journée. Son sommeil est perturbé, avec des réveils précoces, et elle dit avoir du mal à interrompre les pensées liées à son travail, qui reviennent de manière répétée. Elle évoque également un sentiment de perte de confiance en elle et de remise en question de ses compétences.

Elle occupe ce poste depuis six ans. Elle parle de ses débuts comme d'une période satisfaisante, marquée par le contact avec les clients et la possibilité de construire des relations dans la durée. Elle dit s'être sentie reconnue dans son travail, tant par sa hiérarchie que par les résultats qu'elle obtenait.

La situation évolue avec l'arrivée d'un nouveau responsable d'agence, environ un an auparavant. De nouvelles modalités de fonctionnement sont mises en place, avec des objectifs chiffrés élevés et une mise en comparaison régulière des performances entre collègues. Dans ce contexte, Madame C. a le sentiment d'être particulièrement exposée aux remarques de ce responsable, qui souligne de manière répétée ce qu'il considère comme des insuffisances dans son travail.

Elle décrit des situations où son activité est critiquée devant les autres, ainsi que des échanges où ses compétences sont remises en cause. Parallèlement, elle remarque qu'elle n'est plus associée à certains moments informels, que ses demandes d'aide restent sans réponse et que ses initiatives sont fréquemment contestées. Elle évoque aussi des consignes qui lui semblent difficiles à suivre, parfois contradictoires, et qui la placent dans des situations où elle a le sentiment de ne pas pouvoir répondre correctement aux attentes.

Au fil du temps, elle a le sentiment que sa place dans l'équipe se transforme. Les relations avec ses collègues deviennent plus distantes, chacun semblant concentré sur ses propres objectifs. Elle dit se sentir de plus en plus seule face aux difficultés rencontrées.

Elle décrit une appréhension croissante à l'idée de se rendre au travail. Pour faire face, elle passe davantage de temps à vérifier ses dossiers, prolonge ses journées et a du mal à s'arrêter une fois rentrée chez elle. Malgré cela, elle a le sentiment que cela ne suffit pas à répondre aux attentes. Elle évoque également l'apparition de douleurs physiques, une perte d'appétit et une fatigue importante.

Un moment lui apparaît comme particulièrement marquant : lors d'un entretien d'évaluation, elle reçoit une appréciation très négative de son travail, accompagnée de la perspective de sanctions. Elle décrit à ce moment-là une perte de contrôle émotionnel, avec des pleurs et la sensation de ne plus savoir comment faire face à la situation. Elle dit avoir eu l'impression de « ne plus exister » dans son travail.

Depuis, elle oscille entre le souhait de continuer à tenir et l'idée de quitter son poste, sans parvenir à se projeter clairement. Elle insiste sur le contraste entre l'attachement qu'elle avait à son métier et la difficulté actuelle à y trouver une place.

16. Monsieur L. – Travail prescrit et vécu de l'activité

Monsieur L., quarante-deux ans, travaille comme technicien de maintenance dans une entreprise industrielle. Il est adressé en consultation par son médecin traitant. Depuis plusieurs mois, il décrit une fatigue qui s'accumule, avec la sensation de ne plus récupérer malgré les périodes de repos. Il évoque également des difficultés à organiser ses journées, avec le sentiment d'être souvent débordé sans parvenir à identifier précisément ce qui lui prend autant de temps.

Il occupe ce poste depuis une dizaine d'années. Il explique qu'il connaissait bien les installations dont il avait la charge et qu'il appréciait la dimension concrète de son travail, notamment les interventions sur le terrain et la résolution de pannes. Il dit avoir développé, au fil du temps, une bonne connaissance des équipements et une certaine autonomie dans l'organisation de ses interventions.

Depuis environ un an, son activité a évolué avec l'introduction de nouveaux outils numériques. Les interventions sont désormais planifiées et suivies à l'aide d'un logiciel, qui impose des procédures détaillées à chaque étape. Il doit renseigner de nombreuses informations après chaque intervention et suivre des protocoles standardisés, y compris dans des situations qu'il juge peu adaptées à ce type de formalisation.

Monsieur L. explique qu'il a parfois l'impression de passer plus de temps à remplir des comptes rendus qu'à intervenir sur les équipements. Il dit devoir régulièrement interrompre une tâche pour renseigner le système ou vérifier qu'il respecte bien les étapes attendues. Il lui arrive de revenir sur ses interventions pour compléter des informations demandées a posteriori.

Il évoque aussi une difficulté croissante à se repérer dans son travail. Certaines interventions lui paraissent plus fragmentées, moins lisibles, et il dit avoir parfois le sentiment de ne pas « finir » ce qu'il a commencé. Il lui arrive d'oublier certaines actions ou de devoir vérifier plusieurs fois ce qu'il a fait.

Dans ce contexte, il se sent moins sûr de lui. Il redoute de commettre des erreurs, notamment lorsqu'il doit intervenir dans des situations urgentes. Il décrit des moments où il hésite davantage, prend plus de temps pour décider, ou sollicite ses collègues pour des questions qu'il aurait auparavant traitées seul.

Les échanges avec ses collègues ont également évolué. Il explique que chacun est davantage centré sur ses propres interventions, avec moins de moments informels pour discuter du travail. Les réunions portent principalement sur le suivi des indicateurs et le respect des procédures.

En dehors du travail, il dit continuer à penser à certaines interventions, notamment lorsqu'il a un doute sur ce qu'il a fait. Il se sent plus tendu et remarque qu'il a moins d'énergie pour ses activités habituelles.

Lorsqu'il parle de sa situation, il insiste sur le fait qu'il a toujours su faire son travail, mais qu'il a aujourd'hui le sentiment que « ça lui échappe un peu », sans pouvoir dire exactement pourquoi.

17. Claire : exigences de formation et sentiment de ne pas être à la hauteur

Claire, vingt-trois ans, est étudiante en quatrième année de médecine. Elle consulte à la demande du service de santé universitaire. Depuis plusieurs mois, elle décrit une fatigue persistante, accompagnée de difficultés à se concentrer lors des cours et des stages. Elle dit avoir du mal à maintenir son attention sur de longues périodes et se surprend à relire plusieurs fois les mêmes informations sans parvenir à les mémoriser.

Elle évoque également une appréhension croissante à l'approche des évaluations, avec des moments où elle a le sentiment de « perdre ses moyens », notamment lors des examens oraux. Son sommeil est irrégulier, et elle se réveille parfois en pensant à ce qu'elle doit faire le lendemain.

Claire a toujours eu de bons résultats scolaires. Elle décrit un parcours sans difficulté particulière jusque-là, marqué par un investissement important dans ses études. Elle dit avoir choisi médecine par intérêt pour le soin et le contact avec les patients.

Depuis son entrée dans les années cliniques, elle découvre le fonctionnement des stages hospitaliers. Elle décrit des journées longues, alternant présence en service, enseignements et travail personnel. Elle dit avoir du mal à trouver un rythme qui lui permette de faire face à l'ensemble des exigences.

En stage, elle évoque des situations où elle ne sait pas toujours ce qui est attendu d'elle. Elle hésite à poser des questions, de peur de déranger ou de donner une image négative d'elle-même. Elle dit parfois avoir l'impression de « ne pas être à la hauteur ».

Dans ce contexte, elle consacre de plus en plus de temps à son travail personnel, au détriment de ses activités de loisir. Elle a progressivement réduit ses sorties et ses moments de détente, avec l'idée de compenser ce qu'elle pense ne pas maîtriser. Malgré cela, elle a le sentiment que ses efforts ne suffisent pas.

Elle décrit aussi une évolution de ses relations avec les autres étudiants. Elle se compare davantage à ses pairs, en particulier à ceux qu'elle perçoit comme plus à l'aise. Elle dit éviter certaines discussions autour des résultats ou des stages, qui renforcent son sentiment de décalage.

En dehors des études, elle a du mal à se détendre. Même lorsqu'elle ne travaille pas, elle pense à ce qu'elle devrait faire. Elle se sent souvent préoccupée et dit avoir l'impression que « tout tourne autour des études ».

Lorsqu'elle évoque sa situation, elle oscille entre l'idée qu'elle doit faire davantage d'efforts et la sensation de ne plus savoir comment s'y prendre. Elle insiste sur son envie de poursuivre ses études, tout en exprimant une inquiétude quant à sa capacité à continuer dans ces conditions

18. Lucas : difficultés cognitives et perte de repères dans les études

Lucas, vingt et un ans, est étudiant en deuxième année de licence de droit. Il consulte au service de santé universitaire à la suite de difficultés apparues progressivement depuis plusieurs mois. Il décrit des problèmes de concentration de plus en plus fréquents, avec la sensation de ne pas parvenir à maintenir son attention lorsqu'il travaille. Il dit avoir du mal à suivre les cours, notamment lorsqu'ils sont longs, et se surprend à « décrocher » sans s'en rendre compte.

Lorsqu'il étudie seul, il lui arrive de relire plusieurs fois les mêmes pages sans parvenir à en retenir le contenu. Il évoque également des difficultés à organiser son travail : il commence certaines tâches sans les terminer, passe d'un sujet à un autre, et a du mal à hiérarchiser ce qu'il doit faire. Il lui arrive d'oublier des consignes ou des échéances, ce qui ne lui arrivait pas auparavant.

Lucas explique qu'il avait jusque-là un parcours scolaire plutôt stable, sans difficulté particulière. Il dit qu'il arrivait à travailler efficacement, notamment en période d'examen, et qu'il savait comment s'organiser.

Depuis le début de l'année universitaire, il décrit une impression de désordre dans son travail. Les cours lui paraissent plus abstraits, les attentes moins explicites, et il dit avoir du mal à comprendre ce qui est réellement important. Il évoque une sensation de dispersion, comme s'il n'arrivait plus à « accrocher » les informations entre elles.

Dans ce contexte, il passe plus de temps à travailler, sans pour autant avoir le sentiment d'avancer. Il dit que ses journées sont souvent peu productives, ce qui le conduit à prolonger ses temps de travail le soir. Malgré cela, il a l'impression de ne pas retenir ce qu'il apprend.

Lors des examens, il décrit des moments où il ne parvient pas à mobiliser ses connaissances. Il dit avoir « le trou » sur des notions pourtant travaillées, ou avoir du mal à organiser ses idées à l'écrit.

En dehors des études, il se sent fatigué et moins disponible pour ses activités habituelles. Il passe davantage de temps seul et dit avoir du mal à se détendre. Il remarque aussi qu'il pense souvent à son travail universitaire, même lorsqu'il essaie de faire autre chose.

Il évoque une inquiétude croissante face à ces difficultés, qu'il ne s'explique pas. Il dit ne pas se reconnaître dans cette manière de fonctionner et craint que cela compromette la suite de ses études.

19. Nadia : évaluation permanente, objectifs inatteignables

Nadia, vingt-huit ans, travaille comme commerciale dans une entreprise de services.

Elle est adressée en consultation par son médecin traitant. Depuis plusieurs mois, elle décrit une fatigue importante, associée à une tension constante dans son travail.

Elle dit avoir le sentiment d'être en permanence « sous pression », avec la sensation de ne jamais en faire assez.

Elle occupe ce poste depuis trois ans. Elle évoque un début de parcours satisfaisant, marqué par une certaine autonomie dans l'organisation de son travail et des relations de confiance avec ses clients. Elle dit avoir trouvé un équilibre qui lui permettait d'atteindre ses objectifs tout en maintenant une qualité de relation qu'elle jugeait importante.

Depuis environ un an, les modalités d'évaluation ont évolué. De nouveaux indicateurs ont été introduits, avec un suivi très précis de son activité : nombre d'appels, taux de transformation, durée des échanges, chiffre d'affaires réalisé. Ces données sont mises à jour régulièrement et comparées à celles des autres membres de l'équipe.

Nadia explique qu'elle consulte fréquemment ces indicateurs au cours de la journée.

Elle dit avoir du mal à s'en détacher, avec le sentiment que chaque action peut avoir un impact immédiat sur son classement. Elle évoque des objectifs qui lui paraissent difficiles à atteindre, notamment dans un contexte où certains clients se montrent moins disponibles ou plus hésitants.

Elle décrit des journées très rythmées, avec peu de temps de pause, durant lesquelles elle enchaîne les appels. Elle dit parfois écourter certaines conversations pour pouvoir en traiter davantage, tout en ayant le sentiment que cela dégrade la qualité des échanges.

Malgré ses efforts, elle constate que ses résultats ne correspondent pas toujours aux attentes. Elle dit avoir l'impression de « courir après quelque chose » sans jamais y parvenir complètement. Les moments où elle atteint ses objectifs lui procurent un soulagement temporaire, rapidement remplacé par la pression des objectifs suivants.

Elle évoque également des réunions d'équipe au cours desquelles les résultats sont présentés et comparés. Elle dit ressentir une certaine tension lors de ces moments, notamment lorsqu'elle se situe en dessous des attentes. Elle décrit un climat où chacun semble attentif à sa position par rapport aux autres.

Dans ce contexte, elle a progressivement modifié sa manière de travailler. Elle se focalise davantage sur les indicateurs que sur le contenu des échanges, et dit parfois avoir le sentiment de « faire du chiffre » plutôt que son métier. Elle passe aussi plus de temps à travailler, y compris en dehors des horaires prévus.

En dehors du travail, elle dit avoir du mal à se détendre. Elle pense souvent à ses résultats et à ce qu'elle pourrait faire différemment. Elle se sent fatiguée et moins disponible pour son entourage.

Lorsqu'elle évoque sa situation, elle insiste sur le fait qu'elle souhaite réussir dans son travail, mais dit ne plus savoir comment s'y prendre. Elle a le sentiment que les attentes sont toujours repoussées et qu'il devient difficile de trouver un point d'équilibre.

20. Karim : impossibilité de faire un travail de qualité

Karim, trente-cinq ans, travaille comme aide à domicile auprès de personnes âgées. Il est adressé en consultation par son médecin traitant. Depuis plusieurs mois, il décrit une fatigue persistante et un malaise qu'il associe directement à son travail. Il évoque une tension récurrente au moment de commencer sa journée, avec le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'il estime nécessaire auprès des personnes qu'il accompagne.

Il exerce ce métier depuis près de huit ans. Il insiste sur l'importance qu'il accorde à la relation avec les bénéficiaires, à la prise en compte de leurs habitudes et à la manière de les accompagner dans leur quotidien. Il décrit son travail comme reposant autant sur les gestes techniques que sur l'attention portée aux personnes.

Depuis quelque temps, l'organisation de son travail a évolué. Les tournées ont été réorganisées, avec des temps d'intervention plus courts et des déplacements plus nombreux. Les plannings sont ajustés régulièrement, parfois à la dernière minute, et il lui arrive d'enchaîner plusieurs interventions sans temps de transition.

Karim explique qu'il doit désormais se concentrer sur les tâches strictement prévues : aide à la toilette, préparation des repas, entretien du logement. Il dit avoir moins de temps pour échanger avec les personnes, alors que ces moments faisaient auparavant partie intégrante de son travail. Il lui arrive de devoir interrompre une conversation pour respecter son planning.

Certaines situations le marquent particulièrement. Il évoque des moments où il quitte un domicile en ayant le sentiment de laisser la personne seule, sans avoir pu prendre le temps nécessaire. Il dit repenser à ces situations après sa journée, avec l'impression de ne pas avoir fait correctement son travail.

Pour faire face, il tente parfois de « prendre un peu plus de temps », en décalant légèrement son planning. Mais cela a des répercussions sur le reste de sa journée, qu'il doit ensuite accélérer. Il se retrouve alors à enchaîner les interventions plus rapidement, avec le sentiment de devoir compenser.

Il décrit également une évolution de ses relations avec ses collègues. Les échanges sont plus rares, chacun étant pris par son propre planning. Il dit ne pas vraiment avoir d'espace pour partager ces difficultés.

En dehors du travail, il se sent préoccupé par certaines situations. Il lui arrive de penser aux personnes qu'il accompagne et de se demander s'il a fait ce qu'il fallait. Il dit avoir du mal à se détendre complètement.

Lorsqu'il parle de son métier, il insiste sur le fait qu'il continue à y être attaché. Mais il exprime aussi le sentiment que « ce n'est plus comme avant », et que ce qui comptait pour lui dans ce travail devient plus difficile à maintenir.